UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

CHIRURGIE PEDIATRIQUE / PEDIATRIE
Invagination intestinale aiguë (SUJET 2)
Avec patient simulé
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Chokron Léa **Date de rédaction : Novembre 2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 004 – Douleur abdominale

N° 013 – Nausées / vomissements

N°10 – Méléna / rectorragies

Domaine de compétence n°1 : Entretien/interrogatoire

Domaine de compétence n°2 (en sélectionner 1 SEUL) : Annonce

Attendus d'apprentissage de la situation abordée

(Cf. LISA : Catégorie : Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)) **:**

1- Interroger sur l'installation de la douleur et ses caractéristiques

2- Savoir émettre une hypothèse diagnostique principale et l'expliquer au patient

Patient simulé nécessaire à la station : OUI (mère ou père de l'enfant)

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Accessoire nécessaire : carnet de santé à disposition

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synopsis :

Vous êtes la maman du jeune Balthazar, 9 mois, qui présente depuis 2-3 jours un comportement inhabituel et semble avoir des douleurs abdominales. Ce matin, Balthazar a fait un malaise, est devenu tout pale, ce qui vous a incité à consulter.
Un étudiant en médecine va vous interroger.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	ENFANT: Nom: Milo Prénom: Balthazar MAMAN (vous) : Mme Sophie Milo Age de l'enfant: 9 mois Une sœur de 3 ans sans antécédents particulier
Antécédents	Aucun antécédent particulier Né prématurément à 36 SA 2700g Allaitement, diversification à 5 mois, sans particularité
VACCINATION : à jour	**CARNET DE SANTE A DISPOSITION si demandé**
Médicaments / Toxiques	*NON*
Etats d'esprit/ comportement	Comportement : - renfermé, ne joue plus -Pleurs et gémissements par crises - Enfant irritable - REFUS du biberon Angoisse : forte pour la maman
Déroulement du scénario	Vous êtes assise, inquiète, et consultez pour votre enfant Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *"Depuis quelques jours, le comportement de Balthazar est particulier, il semble avoir des douleurs. Il a même fait un malaise ce matin.*" Puis répondez aux questions de l'étudiant selon le tableau si dessous en ne dévoilant que les informations qu'il vous demande spécifiquement.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par L'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »	
Depuis quand Balthazar a-t-il mal ? Y a-t-il eu un élément déclencheur ?	Depuis 2 jours Pas à ma connaissance, les premiers cris sont apparus pendant la sieste
Arrivez-vous à localiser la douleur ?	Plutôt au niveau abdominal j'ai l'impression
Les douleurs sont-elles constantes ?	Non, pas vraiment. C'est plutôt par crises, avec des périodes où il semble ne plus avoir mal.
Les douleurs ont-elles évolués depuis le début ?	Oui, les crises sont de plus en plus rapprochées, et de plus en plus intenses
Les douleurs sont-elles calmées ou aggravées par quelque chose ?	Non, je n'en ai pas l'impression
Les pleurs/les douleurs sont-ils également la nuit ?	OUI
Est-ce que vous pouvez préciser le malaise ?	Oui, il semble faire comme des petits malaises où il devient tout blanc, tout pale Beaucoup de pleurs et de cris
Le comportement de Balthazar est-il modifié par rapport à d'habitude ?	Il est soit très agité soit au contraire trop calme. Il cesse de jouer, présente des accès de cris et de pleurs inconsolables, ne se nourrit plus.
Y a-t-il eu une éruption cutanée ?	NON
Y a-t-il eu des vomissements associés ?	Oui
Caractérisation des vomissements Comment sont-ils ? Quelle couleur ?	D'abord avec des résidus alimentaires puis plutôt jaune/verdâtre (bilieux)
Vomissements en jet ?	NON
Le transit est-t-il particulier ?	OUI, diminution de la fréquence des selles avec diarrhée
Y a-t-il eu du sang dans les selles ?	Oui, ce matin seulement, un peu de sang dans les selles
Du sang dans les urines ?	NON
L'alimentation de Balthazar est-elle différente ?	Oui, il mange de moins en moins depuis 3 jours et a complètement refusé le biberon ce matin

A-t-il perdu du poids ?	Je ne l'ai pas pesé mais j'ai l'impression oui
Est-ce la première fois qu'il fait ce genre d'épisode ?	Oui
A-t-il eu de la fièvre ?	NON
A-t-il eu un épisode infectieux récemment ?	OUI, un rhume il y a une semaine

Instructions à l'étudiant

Vous êtes pédiatre de ville et recevez Mme Milo qui vous consulte pour son fils Balthazar, 9 mois. Il présente depuis quelques jours un changement de comportement et des pleurs inconsolables.
Elle vous consulte suite à un malaise de Balthazar ce matin et la persistance des pleurs.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réaliser l'interrogatoire **ciblé** du parent à visée étiologique
2. Expliquer votre principale hypothèse diagnostique au parent et l'examen à réaliser pour la confirmer

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Recherche le site de la douleur	
Recherche la temporalité de la douleur (*par crise)*	
Recherche l'évolution / l'intensité de la douleur (*de plus en plus rapprochées*)	
Recherche le caractère également nocturne de la douleur	
Recherche le développement psychomoteur global de l'enfant	
Précise le changement du comportement globale de l'enfant	
Recherche de vomissements	
Explore l'aspect des vomissements (alimentaire puis bilieux)	
Recherche une modification du transit (*OK si vomissement ou diarrhée*)	
Recherche de rectorragies	
Exploration du malaise (*aspect de l'enfant*)	
Explore l'alimentation actuelle de l'enfant	
Recherche d'un épisode infectieux récent *(facteur de risque ou diag différentiel, adénolymphite mésentérique)*	
Tache 2	
Énonce le diagnostic d'invagination intestinale aiguë (primitive)	
Explique le diagnostic au parent en termes simples	
Précise le caractère urgent de la prise en charge	
Explique la nécessité d'une échographie abdominale pour confirmer le diagnostique	
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE A QUESTIONNER	1 à 5
APTITUDE A STRUCTURER / MENER l'ENTREVUE	1 à 5
APTITUDE A FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AUX PARENTS	1 à 5

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération entre 1 et 5
Tache 1	
Recherche le site de la douleur	3
Recherche la temporalité de la douleur (par crise)	5
Recherche l'évolution / l'intensité de la douleur (de plus en plus rapprochées)	2
Recherche le caractère également nocturne de la douleur	2
Recherche une modification du comportement globale de l'enfant	2
Recherche de vomissements	3
Explore l'aspect des vomissements (alimentaire puis bilieux)	2
Recherche une modification du transit	1
Recherche de rectorragies	2
Exploration du malaise (aspect de l'enfant)	2
Explore l'alimentation actuelle de l'enfant	5
Recherche d'un épisode infectieux récent (facteur de risque)	1
	/30
Tache 2	
Énonce le diagnostic d'invagination intestinale aiguë (*primitive*)	5
Explique le diagnostic au parent en termes simples (*en précisant entre autres le caractère urgent)*	3
Explique la nécessité d'une échographie abdominale pour confirmer le diagnostique	2
	/40
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE A QUESTIONNER	1 à 5
APTITUDE A STRUCTURER / MENER l'ENTREVUE	1 à 5
APTITUDE A FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AUX PARENTS	1 à 5
Note totale	/ 55